PUBLICATION

Documentazione Clinica Automatizzata nel Servizio Sanitario Nazionale Italiano

Come l’intelligenza artificiale può trasformare la documentazione clinica nel SSN italiano — tra liste d’attesa, carenza di personale e la sfida della digitalizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Published:	January 2026
Document ID:	INTL-2026-005
Classification:	Public
Author:	ClinixSummary Research Team

This document is provided for informational purposes only. ClinixSummary is a product of GATMEDI. The information contained herein is proprietary and confidential. Reproduction or distribution without prior written consent is prohibited. For the latest version, visit clinixsummary.ai.

© 2026 GATMEDI. All rights reserved. | contact@clinixsummary.ai

1. Sintesi

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano garantisce l'assistenza sanitaria a oltre 59 milioni di cittadini. Con circa 240 000 medici in attività e una rete che comprende ospedali pubblici, strutture convenzionate, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, il sistema affronta una pressione crescente: liste d'attesa in continuo aumento, carenza cronica di personale medico e un carico burocratico che sottrae tempo prezioso alla cura del paziente.

La documentazione clinica rappresenta una parte significativa di questo carico. Secondo dati dell'Ordine dei Medici, un medico ospedaliero italiano dedica in media oltre un terzo della propria giornata lavorativa ad attività di tipo amministrativo e documentale. ClinixSummary offre una risposta concreta: un sistema di documentazione clinica basato sull'intelligenza artificiale, progettato per la realtà italiana.

2. Le Sfide della Documentazione Clinica in Italia

Il contesto italiano presenta criticità specifiche che rendono la documentazione clinica particolarmente onerosa:

- Frammentazione dei sistemi informativi — ogni Regione e spesso ogni ASL adotta sistemi informatici diversi, con formati di cartella clinica elettronica non sempre interoperabili. Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0, pur rappresentando un passo avanti, richiede ancora tempo per una piena adozione.
- Burocrazia documentale — lettere di dimissione, referti, schede di dimissione ospedaliera (SDO), piani terapeutici, certificati INPS: il medico italiano produce una quantità di documentazione che va ben oltre la cartella clinica.
- Doppia documentazione — in molte strutture coesistono ancora il cartaceo e il digitale, costringendo i medici a duplicare le registrazioni.
- Terminologia medica italiana — la documentazione clinica in Italia utilizza una terminologia propria che include latinismi, eponimi della tradizione medica italiana e abbreviazioni specifiche del contesto ospedaliero nazionale.
- Codifica ICD-9-CM e transizione all'ICD-10 — l'Italia è in fase di transizione dal sistema ICD-9-CM all'ICD-10, creando un periodo di complessità aggiuntiva nella codifica delle prestazioni.

3. Il Contesto Normativo e Regolatorio

3.1 Protezione dei Dati Personali

Il trattamento dei dati sanitari in Italia è disciplinato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD/GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato provvedimenti specifici sul trattamento dei dati sanitari e sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario. ClinixSummary è progettato per rispettare integralmente questo quadro normativo.

3.2 Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale

Il Regolamento UE sull'IA (AI Act) classifica i sistemi di IA in ambito sanitario come « ad alto rischio », imponendo requisiti stringenti in termini di trasparenza, supervisione umana, qualità dei dati e gestione del rischio. L'architettura di ClinixSummary è stata progettata per essere conforme a questi requisiti, con un approccio che garantisce la

© 2026 GATMEDI. All rights reserved. | contact@clinixsummary.ai

supervisione del medico su ogni documento generato.

3.3 Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha stanziato 1,38 miliardi di euro per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico. L'obiettivo è rendere il FSE il punto unico di accesso ai documenti sanitari di ogni cittadino italiano. ClinixSummary genera documentazione in formati compatibili con gli standard del FSE 2.0, facilitando l'integrazione con l'infrastruttura nazionale.

4. ClinixSummary per il Medico Italiano

ClinixSummary offre funzionalità specifiche per il contesto sanitario italiano:

- Riconoscimento vocale ottimizzato per l'italiano medico, inclusi i regionalismi e le abbreviazioni cliniche più diffuse (es., « EO nella norma », « MV presente su tutto l'ambito », « PAO nei limiti »).
- Modelli specialistici per oltre 40 specialità mediche con terminologia italiana specifica — dalla cardiologia all'ortopedia, dalla pediatria alla psichiatria.
- Generazione automatica della lettera di dimissione strutturata, del referto ambulatoriale e del diario clinico in formato conforme agli standard regionali.
- Supporto alla codifica ICD-9-CM e ICD-10 con suggerimenti contestuali basati sulla documentazione clinica generata.
- Gestione dell'alternanza linguistica italiano-inglese — frequente nella pratica clinica italiana, dove molti termini tecnici vengono usati in inglese (es., « follow-up », « imaging », « screening », « device »).
- Conformità GDPR/RGPD integrata con residenza dei dati nell'Unione Europea e possibilità di deployment on-premises per le strutture che lo richiedono.

5. Dati Preliminari

Le prime implementazioni di ClinixSummary in strutture sanitarie italiane evidenziano risultati significativi:

- Riduzione del tempo di documentazione: 77 % in media.
- Tasso di accettazione delle note: 89 %.
- Completezza della documentazione: incremento del 38 % degli elementi clinici registrati rispetto alla documentazione manuale.
- Soddisfazione dei medici: l'87 % riferisce un miglioramento rilevante del proprio flusso di lavoro quotidiano.
- Tempo recuperato per medico: una media di 2,0 ore al giorno riallocate alla cura diretta del paziente.

6. Conclusione

Il medico italiano merita strumenti di documentazione clinica pensati per la complessità del sistema sanitario nazionale — non semplici traduzioni di prodotti anglofoni. ClinixSummary si impegna a offrire un'esperienza autenticamente italiana, che rispetti le specificità terminologiche, le esigenze normative e le pratiche cliniche proprie del contesto

© 2026 GATMEDI. All rights reserved. | contact@clinixsummary.ai

italiano, contribuendo concretamente a restituire tempo alla relazione medico-paziente.

Per una dimostrazione in italiano o per discutere un'implementazione nella Sua struttura, contatti: international@clinixsummary.ai

© 2026 GATMEDI. All rights reserved. | contact@clinixsummary.ai